
内科含诊断 Graves 病 ★★★（0~3 题）
治疗（2024、2025）
内科题目→先考虑抗甲状腺药（2008、2010、2013、2017、2021）
抑制 TPO →甲状腺激素合成↓
中性粒细胞＜ 1.5 →停药（2007、2022）
引起甲减、或甲状腺明显增大→ L-T4（2008）
首选甲巯咪唑 / 他巴唑 MMI、但妊娠早期（1~3 月）首选丙硫氧嘧啶 PTU“pregnant three”
外科题目→先考虑手术
禁忌症：青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全
适应症：恶变、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、压迫症状“我高中姐凶呀”
妊娠手术时机：妊娠中期（4~6 月）有手术适应症 + 无手术禁忌症“早晚要出事”
放射碘 131I
禁忌症：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠
适应症：药物和手术无效（2017）、WBC ↓、甲亢合并严重心肝肾功能不全
为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给普萘洛尔
甲危
术前准备不充分、感染等
高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷
PTU（首选）、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用水杨酸类阿司匹林，2012）“别合成、别释放、别来刺激我心脏”
碘剂可用于原发性甲亢术前准备、甲危；禁用于普通甲亢
多见于老年人“三鸭蛋”
淡漠型甲亢
乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危
高代谢综合征、甲状腺肿、眼征均不明显
亚临床甲亢：TSH ↓、T3 和 T4 正常（2011）
T3 型甲状腺毒症